psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

SUGERENCIAS CLINICAS / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

1.- Antecedentes generales

Nombre del Paciente	Juan Pedro Moreno Palta.

2.- Objetivos

1.- Entrega de estrategias para la consolidación del control de esfínter.
2.- Conocer desafíos dentro del proceso de control de esfínter.

3.- Tipo de sugerencias

Material Escrito	Material manipulativo	Paneles (estructura conducta)	Aplicación tecnológica	Pictogramas varios
x				

3.- Fundamento y explicación de las sugerencias

A.-Factores a considerar:

FACTORES	DESCRIPCIÓN
FACTORES BIOLÓGICOS	Todos los centros y vías nerviosas implicados en el mecanismo de la micción y las estructuras neuromusculares de la vejiga deben estar intactos y madurar adecuadamente. Existe una cierta predisposición genética que influye en la edad a la que se consigue el control del esfínter urinario. Se ha visto que el '75% de los niños con enuresis tienen algún familiar de primer grado con enuresis en la infancia. 666 E. Aleo Luján, B. de Miguel Lavisíer, O. Pérez Rodríguez
FACTORES PSICOSOCIALES	Son los que influyen sobre el aprendizaje. Algunos autores argumentan que si el entrenamiento en el control vesical se inicia antes de los doce meses, se conseguirá su control más fácilmente y la enuresis es más infrecuente. Sin embargo, otros autores refieren que cuando determinados educadores fuerzan al niño en el control de esfínteres a edades muy tempranas pueden suscitar en el niño una reacción airada y un desafío inconsciente que lleva a una ausencia de control miccional. Los refuerzos positivos favorecen el control, mientras que los negativos lo dificultan. Las alteraciones emocionales o acontecimientos estresantes durante el periodo de aprendizaje influyen negativamente (nacimiento de un hermano, comienzo de guardería, cambio de domicilio...).

B.-Principales desafíos para la consolidación:

- ***Aprendizaje:*** A menudo tienen dificultades de aprendizaje, por lo que les puede costar mucho más tiempo el adquirir las habilidades básicas necesarias para ir al cuarto de baño de modo independiente. Puede llevar un año, o incluso más, el que los niños consigan mantenerse secos y dos años o más el que se limpien por sí mismos.

- ***Imitación:*** Dificultad para la imitación de acciones motoras funcionales y durante el juego.

- ***Sensoriales:*** Dificultades en el procesamiento sensorial, por ejemplo, pueden crear reacciones de miedo y rechazo por una hipersensibilidad sensorial o distracción durante el proceso debido a una hipersensibilidad sensorial. También pueden adquirir hábitos de limpieza, o mantenerse secos, pero no ambas cosas a la vez. Algunos niños orinarán sin problemas en el wc, pero rehusarán sentarse para defecar. Pueden sentirse preocupados por salpicarse con el agua.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

SUGERENCIAS CLINICAS / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

- **Lenguaje:** A menudo tienen problemas para aprender y utilizar el lenguaje. Puede que no sean capaces de decir que necesitan ir al wc con palabras, así que debe atender a otros signos para saberlo.

- ***Inflexibilidad:*** Pueden encontrar difícil el adaptarse de una situación a otra debido a la inflexibilidad cognitiva. Por ello, podría ocurrir que en casa vayan al baño muy a gusto, pero que necesiten pañales en la guardería o en la escuela. Si alguien intenta llevarlos al baño en la escuela, pueden sentirse muy enfadados y tener rabietas.

- ***Patrones o hábitos relacionados con el baño:*** Pueden desarrollar patrones difíciles de comportamiento al ir al wc, tales como desparramar heces por las paredes del baño, en algún otro lugar o sobre sí mismos. Esto puede ser un problema concreto por las noches. También puede que hagan pipí o caca en otras partes, además de hacerlo en el baño. No parecen darse cuenta de que este es un comportamiento completamente inapropiado y por último se da que permiten limpiarlos después de hacer caca, porque se alteran con la idea de ensuciarse en general. Para algunos niños este miedo significa negarse a mover la tripa y se estriñen sufriendo dolor de tripa y otros síntomas.

C.-Estrategias:

- ¿Cómo se puede eliminar el rechazo al inodoro/orinal?
  Asociando el lugar con algo positivo:
  Cada vez que ingrese al baño deberá pegar un stickers en un lugar designado.
  Colocar música como refuerzo positivo posterior al proceso de micción.
  Utilización de ahorro de ficha, cada vez que Juan Pedro logre el proceso pegar en conjunto imagen referencial en el día que corresponda. Al juntar una cierta cantidad entrega un refuerzo positivo tangible. (Anexo 1).

  Manejo ambiental:
  Si se hace pipí encima, le reprenderemos suavemente. Por ejemplo: "NO, aquí no se hace orina, el pipí se hace en el WATER" (poniéndonos serios). Así mismo debemos llevarlo al cuarto de baño para enseñarle el WC e incluso podemos sentarlo un momento para recordarle el lugar conveniente.

  Crear rutinas para los momentos de ir al baño. Se debe asociar con actividades cotidianas.

  Emplear refuerzos inmediatos y muy atractivos de manera consistente cada vez que el niño consiga el objetivo planteado. Debe ser un premio material acompañado de un refuerzo de tipo social, como aplausos, sonrisas, alabanzas, un beso, etc; para que éste vaya adquiriendo más valor y significado en la vida del niño. Inicialmente deben ser abundantes y “exagerados” (en el caso de las alabanzas) deben ir siendo menos frecuentes cuando va avanzando en los progresos, hasta desaparecer, aunque siempre debéis manifestar la satisfacción que sentís por el logro conseguido y “lo mayor que es”.

  El papel higiénico a veces se presta a juego o a rechazo, por ello os aconsejamos toallitas húmedas.

  Entorno tranquilo y cómodo: Se pueden utilizar fundas o adaptadores para la taza, escalones o banquitos para que no le cuelguen los pies y consiga mayor sensación de estabilidad.

  Apoyos visuales: Como una secuencia de acciones a seguir en pictogramas. (Anexo 2) En función de la edad y capacidad de comprensión del niño, la secuencia puede ser más corta o más larga. Ejemplos:
  - Sentarse y orinar, limpiarse, tirar de la cadena.
  - Encender la luz, bajar los pantalones, sentarse en el inodoro, orinar, limpiarse, subirse los pantalones, tirar de la cadena, lavarse las manos, apagar la luz.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

SUGERENCIAS CLINICAS / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

D.-Acciones a evitar:

No es conveniente obligarle a sentarse en el orinal si se niega a ello.

No insistir en que orine haciendo fuerza si no lo logra al primer intento.

No reñir, ni castigar, ni avergonzar, porque se haga encima.

No dispersar los esfuerzos cambiando de técnica continuamente, ni usar distintos métodos simultáneamente.

No se le debe reprender excesivamente ni manifestar asco si le vemos jugar con sus deposiciones. Siente curiosidad por aquello que sale de su cuerpo y lo considera como algo valioso e importante.

No le pondremos pañales cuando salgamos a la calle porque lo estaríamos confundiendo. Llevaremos ropa de cambio suficiente.

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

SUGERENCIAS CLINICAS / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Anexo 1

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
PIPI							
CACA							

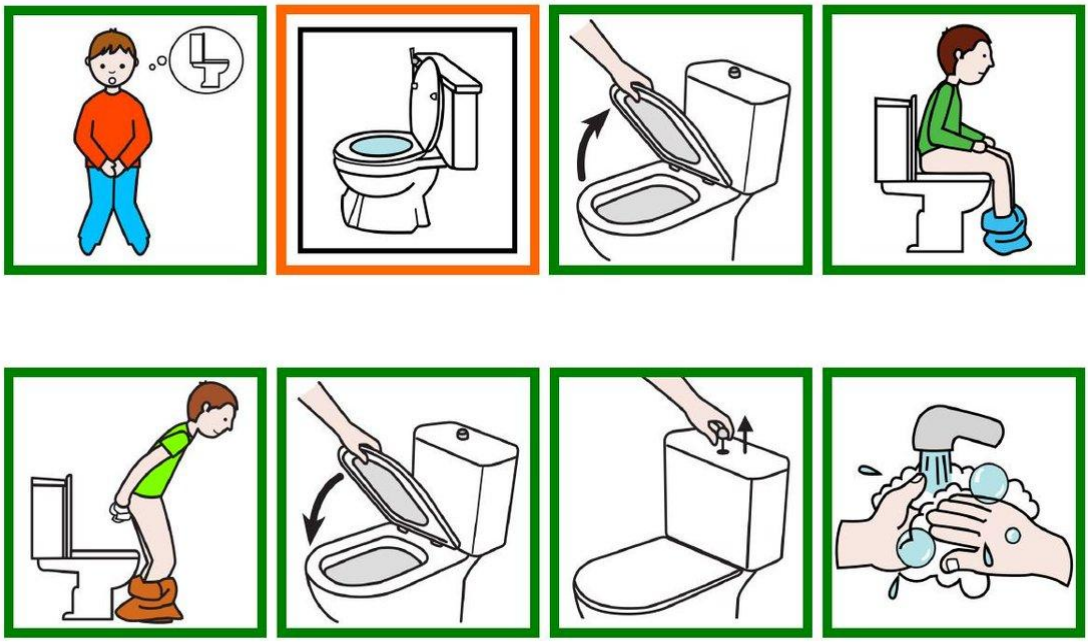
psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

SUGERENCIAS CLINICAS / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

psicoeduka
CENTRO NEUROCOGNITIVO INFANTO JUVENIL

SUGERENCIAS CLINICAS / ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

Anexo 2



Profesionales **Grupo Psicoeduka**	**Valeska Ananías Gómez** **Directora Clínica** **Grupo Psicoeduka**	**Coordinación** **Grupo Psicoeduka**